

CAMDEX-ID

MANUAL

Prueba de Exploración
CAMBRIDGE
para la Valoración de los
Trastornos Mentales en Adultos
con Síndrome de Down o
con Discapacidad Intelectual

S. Ball • T. Holland • F. Huppert • P. Treppner • K. Dodd



Adaptación española:

S. Esteba-Castillo
R. Novell i Alsina
M. Vilà i Alsina
N. Ribas i Vidal



tea
ediciones

CAMDEX•DS

**Prueba de Exploración CAMBRIDGE para la
Valoración de los Trastornos Mentales en Adultos
con Síndrome de Down o con Discapacidad Intelectual**

Sara Ball
Tony Holland
Felicia Huppert
Peter Treppner
Karen Dodd

Adaptación española:
Susanna Esteba-Castillo
Ramon Novell i Alsina
Marta Vilà i Alsina
Núria Ribas i Vidal



MANUAL



Madrid, 2013

Título de la obra original:

CAMDEX-DS. The Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with Down's Syndrome and Others with Intellectual Disabilities.

Adaptación española: Susanna Esteba-Castillo, Ramon Novell i Alsina, Marta Vilà i Alsina y Núria Ribas i Vidal.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Copyright © 2006 by Cambridge University Press, Edinburg Building, Cambridge CB2 2RU, UK.

Copyright de la edición española © 2013 by TEA Ediciones, S.A.U., Madrid, España.

I.S.B.N.: 978-84-15262-94-7

Depósito Legal: M-xxxxx - 2013

ÍNDICE



ACERCA DE LOS ADAPTADORES.....	5
AGRADECIMIENTOS DE LA VERSIÓN ORIGINAL.....	7
PRÓLOGO A LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA.....	9
FICHA TÉCNICA	11
1. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Antecedentes	14
1.2. Aplicaciones	14
1.3. Validez y fiabilidad.....	15
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMDEX-DS.....	17
2.1. Contenidos.....	17
2.1.1. El inventario CAMDEX-DS.....	18
2.1.2. Guía para el diagnóstico clínico	20
2.1.3. Directrices para la intervención tras el diagnóstico	20
2.2. Materiales.....	21
2.3. Aplicación del inventario	21
2.3.1. Tiempo de aplicación	21
2.3.2. Consideraciones especiales	21
2.3.3. Normas de puntuación	21
2.3.4. Normas de interpretación.....	22
2.4. Utilización del CAMDEX-DS para llegar a diagnósticos operativos	22
2.4.1. Procedimientos diagnósticos	22
2.4.2. Gravedad de la demencia	23
3. ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CAMDEX-DS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA.....	25
3.1. Introducción	25
3.2. Material y métodos	27
3.2.1. Sujetos	27
3.2.2. Instrumentos	27
3.2.3. Procedimiento y recogida de datos	29
3.2.4. Análisis estadísticos	29
3.2.5. Descripción de la muestra	30

3.3. Propiedades psicométricas.....	31
3.3.1. <i>Fiabilidad del CAMDEX-DS</i>	31
3.3.2. <i>Concordancia con los criterios diagnósticos</i>	31
3.3.3. <i>Consistencia interna del CAMCOG-DS</i>	31
3.3.4. <i>Puntuaciones en el CAMCOG-DS de pacientes con etiología de SD</i>	33
3.3.5. <i>Puntuaciones en el CAMCOG-DS de pacientes con DI de otras etiologías (no SD)</i>	34
3.3.6. <i>Estudio de la sensibilidad y la especificidad</i>	35
3.4. Discusión	36
4. GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO	39
4.1. Sección 1. Diagnóstico diferencial	39
4.2. Sección 2. Criterios diagnósticos de demencia	40
4.2.1. <i>CAMDEX-R. Criterios operativos para el diagnóstico de demencia y de demencia tipo Alzheimer</i>	42
4.2.2. <i>DSM-IV. Criterios diagnósticos de demencia tipo Alzheimer</i>	48
4.2.3. <i>CIE-10. Criterios diagnósticos de demencia y de demencia tipo Alzheimer</i>	52
4.2.4. <i>Pautas para la clasificación de la demencia de acuerdo a la gravedad clínica</i>	57
5. DIRECTRICES PARA LA INTERVENCIÓN TRAS EL DIAGNÓSTICO	59
5.1. Sección 1. Guía resumen para la asistencia	59
5.1.1. <i>Introducción</i>	59
5.1.2. <i>Principios rectores</i>	60
5.1.3. <i>Revisar y actualizar</i>	71
5.1.4. <i>Resumen</i>	72
5.2. Sección 2. Lista de control del entorno.....	72
APÉNDICE. ESTUDIO DE VALIDEZ DEL CAMDEX-DS (2004)	77
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91

ACERCA DE LOS ADAPTADORES



Susanna Esteba-Castillo

Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y especialista en Neuropsicología. Su labor asistencial se ha desarrollado fundamentalmente en el campo de la psicogeriatría y de la discapacidad intelectual.

Es profesora del Máster en Neuropsicología y Neurología de la conducta de la UAB desde el año 1996, impartiendo las materias relacionadas con la rehabilitación de los trastornos conductuales en personas con daño cerebral. Como especialista en el área de la discapacidad intelectual ha dedicado los últimos años de su carrera profesional a la aplicación de la evaluación neuropsicológica y cognitiva en personas con discapacidad intelectual, área en la que ha adaptado diferentes instrumentos y escalas de evaluación. Imparte clases sobre los problemas de la conducta y sobre neuropsicología como profesora invitada en diferentes universidades españolas y participa como ponente en eventos relacionados con las personas con discapacidad intelectual.

En el momento de esta publicación, lidera proyectos de investigación relacionados con el estudio de los fenotipos cognitivo-conductuales como el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X-Frágil o el síndrome de Prader-Willi. Participa igualmente en el desarrollo de tecnología informática aplicada a la rehabilitación cognitiva en personas con discapacidad intelectual.

Ramon Novell i Alsina

Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Psiquiatría. Como profesional especializado en el ámbito de la discapacidad intelectual, su amplia experiencia incluye el abordaje de los problemas de la conducta y de las enfermedades mentales más frecuentes en estas personas.

Ha dirigido diferentes servicios asistenciales para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta graves. Actualmente es el jefe del servicio de Discapacidad Intelectual y Salud Mental del Instituto de Asistencia Sanitaria en Girona.

En el ámbito de la investigación desarrolla su labor en diferentes líneas como el estudio del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, la genética en las enfermedades mentales, los problemas de conducta en personas con discapacidad intelectual, los fenotipos conductuales, el tratamiento de la demencia en personas con síndrome de Down y en el autismo, los trastornos del sueño, la adaptación de instrumentos de valoración psicopatológica y el diseño de modelos de servicios para el colectivo con discapacidad intelectual, entre otros.

Marta Vilà i Alsina

.....

Es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Psiquiatría. Actualmente trabaja como psiquiatra especialista en diversas residencias para personas con discapacidad intelectual y atiende consulta ambulatoria en el Servicio Especializado en Salud Mental o Trastornos de conducta en personas con discapacidad intelectual, IAS (Girona).

Ha participado como docente en diversos másteres y postgrados relacionados con la discapacidad intelectual y la salud mental, así como en numerosas jornadas y sesiones formativas sobre psicopatología en personas con discapacidad intelectual.

Núria Ribas i Vidal

.....

Es enfermera diplomada por la Universitat de Girona y especialista en salud mental. En su primera etapa profesional desarrolló su labor asistencial en la Unidad de Psiquiatría de Agudos del Institut d'Assistència Sanitària (Salt, Girona) y, posteriormente, en el ámbito de la discapacidad intelectual en la misma institución.

Ha desarrollado actividad docente durante dos años como profesora asociada en la Escuela de Enfermería de la Universitat de Girona impartiendo la asignatura Enfermería en Salud mental. Ha participado como investigadora colaboradora en proyectos del ámbito de la discapacidad intelectual en relación con aspectos genéticos, correlaciones fenotipo-genotipo, de envejecimiento y de valoración de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.



AGRADECIMIENTOS DE LA VERSIÓN ORIGINAL



El desarrollo del CAMDEX-DS se inició con la investigación de Johnny Hon y fue continuado por Sarah Ball como parte de su tesis doctoral. El desarrollo inicial fue financiado mediante una subvención *Eastern Region R&D*. El apoyo de la *Down's Syndrome Association*, que contaba con la financiación del *Community Fund of the National Lottery* (ahora el *Big Lottery Fund*), y de la *Health Foundation*, con la financiación de la *Chair in Learning Disabilities* de la Universidad de Cambridge, han hecho posible la finalización de este proyecto. Estamos muy agradecidos a todas estas organizaciones.

Nos gustaría agradecer su colaboración a todas las personas que han trabajado en nuestros proyectos de investigación estudiando los efectos de la edad en personas con síndrome de Down y que han permitido el desarrollo del CAMDEX-DS. Nos gustaría dar las gracias en particular a Johnny Hon y a Fran Stevens, quienes estuvieron involucrados activamente en la investigación. Peter Watson, de la *MRC Cognition and Brain Sciences Unit*, proporcionó un asesoramiento estadístico inestimable. Estamos agradecidos a los autores originales del CAMDEX, y especialmente al profesor Sir Martin Roth, por acceder a que pudiéramos utilizar el CAMDEX y también por su asesoramiento. Muchas personas con síndrome de Down, sus familias y cuidadores han apoyado la investigación que sustenta este trabajo. Queremos agradecerles a todos ellos el tiempo que han empleado respondiendo a las preguntas y llevando a cabo las evaluaciones.

El desarrollo final y el lanzamiento de este programa han sido posibles gracias a una colaboración entre la *Down's Syndrome Association* y la *Section of Developmental Psychiatry* de la Universidad de Cambridge. Queremos agradecerles su apoyo y sobre todo el de Carol Boys, la directora ejecutiva.



PRÓLOGO A LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA



Escribir un prólogo es siempre un honor y una responsabilidad. Además, escribir un prólogo para la edición española del CAMDEX-DS constituye una tarea especial, ya que los reconocimientos científicos se enlazan con los sentimientos de amistad hacia los adaptadores.

La ciencia neuropsicológica requiere instrumentos de medida con contenidos adecuados, bien estructurados, adecuadamente estandarizados y con estudios sobre su valor diagnóstico. Como no existe un instrumento genérico y aplicable a todas las situaciones clínicas neuropsicológicas, se han desarrollado –y se desarrollan– instrumentos dirigidos a funciones, entidades clínicas o síndromes específicos.

En este contexto, el CAMDEX-DS aporta una metodología estructurada y estandarizada para el estudio de las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual de otras etiologías. Esta necesidad se concreta en los siguientes objetivos: incorporar en un único instrumento la información necesaria para el diagnóstico clínico de demencia, realizar la descripción de las características de la misma y de su diagnóstico diferencial, estructurar el diagnóstico precoz y preciso de la demencia en personas con síndrome de Down y aportar estrategias de apoyo y tratamiento de los pacientes con el objetivo final de mejorar su calidad de vida. Por este motivo, el instrumento se ha estructurado en tres bloques: el inventario CAMDEX-DS, una guía para el diagnóstico clínico y unas directrices para la intervención tras el diagnóstico:

- ❖ El **inventario CAMDEX-DS** presenta todos los apartados necesarios para delimitar el estado cognitivo (memoria, orientación, funcionamiento mental general, lenguaje, atención, percepción, praxis y funciones ejecutivas), funcional y neuropsiquiátrico de los pacientes. En todos los ámbitos se recoge la información aportada por un informante y por el propio paciente.
- ❖ La **guía para el diagnóstico clínico** está organizada en forma de árbol de diagnóstico diferencial en el que destacan la depresión, el hipotiroidismo y los trastornos sensoriales. A continuación de este apartado se han incluido las tablas de criterios diagnósticos de demencia y de clasificación en función de su gravedad.
- ❖ Las **directrices para la intervención** se dividen en dos partes. En la primera se ofrece una guía resumen para la asistencia y en la segunda, una lista de comprobación del entorno.

El número de personas a las que se puede aplicar este instrumento no es nada desdeñable. Las cifras de prevalencia del deterioro cognitivo que conduce a la demencia en pacientes con síndrome de Down aumentan progresivamente con la edad, hasta un 40% cuando se superan los 50 años de edad. Además, otras entidades clínicas que cursan con discapacidad intelectual también presentan un proceso de deterioro relacionado con la edad, cosa que incrementa el interés del CAMDEX-DS.

La adaptación y validación española, realizada por Susanna Esteba-Castillo, Ramon Novell, Marta Vilà y Núria Ribas destaca por su calidad formal y por la excelencia de los datos psicométricos aportados. Los autores han delimitado adecuadamente la muestra, que consta de 146 sujetos, y han mostrado la aplicabilidad de la prueba. En cuanto a las propiedades psicométricas destacan los excelentes valores de fiabilidad test-retest, la concordancia entre los resultados del test y los criterios de referencia, la consistencia interna y la sensibilidad y especificidad diagnósticas. Los resultados obtenidos no son ajenos a la profesionalidad y experiencia del equipo, no solo en la problemática del síndrome de Down, sino en el amplio abanico de síndromes que cursan con discapacidad intelectual, la patología neuropsicológica general, las técnicas diagnósticas y las aproximaciones de intervención y rehabilitación cognitiva.

El mundo de la discapacidad intelectual queda sumamente enriquecido con esta publicación. El profesional tiene en sus manos un excelente instrumento, diseñado tanto para la actividad asistencial como para la investigación. Obviamente, como toda herramienta clínica y psicométrica, su buen uso depende de la experiencia y del buen juicio clínico del profesional.

Mis sinceras felicitaciones a los autores de la adaptación española y a TEA Ediciones, por emprender y culminar excelentemente el proceso de edición.

Jordi Peña-Casanova

*Sección de Neurología de la Conducta y Demencias. Hospital del Mar. Barcelona
Director del Máster de Neuropsicología y Neurología de la Conducta. Universitat Autònoma de Barcelona*

FICHA TÉCNICA



Nombre:	CAMDEX-DS. <i>Prueba de Exploración Cambridge para la Valoración de los Trastornos Mentales en Adultos con Síndrome Down o con Discapacidad Intelectual.</i>
Nombre original:	CAMDEX-DS. <i>The Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with Down's Syndrome and Others with Intellectual Disabilities.</i>
Autores:	Sarah Ball, Tony Holland, Felicia A. Huppert, Peter Treppner y Karen Dodd.
Procedencia:	Cambridge University Press (2006).
Adaptación española:	Susanna Esteba-Castillo, Ramon Novell i Alsina, Marta Vilà i Alsina y Núria Ribas i Vidal (2013).
Aplicación:	Individual.
Ámbito de aplicación:	Adultos con síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual leve o moderada (<i>a partir de los 30 años de edad aproximadamente</i>).
Duración:	Entrevista al informante (40 minutos). Evaluación del paciente en función del nivel previo de discapacidad intelectual: para niveles de discapacidad intelectual leve una duración aproximada de 35 minutos; para niveles de discapacidad intelectual moderada unos 45 minutos. En los casos de personas con síndrome de Down e importante enlentecimiento, la valoración se puede alargar hasta los 60 minutos.
Finalidad:	Evaluación de las formas más frecuentes de demencia así como de otros trastornos mentales y físicos presentes en personas adultas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual de otra etiología.
Material:	Manual (<i>contiene la guía para el diagnóstico clínico y las directrices para la intervención</i>), cuadernillo de anotación (<i>contiene la entrevista al informante y la evaluación del paciente, que incluye el CAMCOG-DS</i>) y cuaderno de estímulos.

**LA VISUALIZACIÓN
DE ESTAS PÁGINAS
NO ESTÁ DISPONIBLE.**

Si desea obtener más información
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



2

DESCRIPCIÓN DEL CAMDEX-DS



El CAMDEX-DS está basado en el CAMDEX-R. Se diferencia de este último principalmente por poner mayor énfasis en la entrevista al informante como elemento clave para un diagnóstico preciso. Esto está motivado por el conocido hecho de que la combinación de las discapacidades intelectuales adquiridas durante el desarrollo y el posible desarrollo de la demencia puede hacer difícil la obtención de una historia clínica fiable a partir de la información proporcionada por el propio paciente.

Adicionalmente, con el fin de tener en cuenta el cambio sustancial en el nivel de capacidad cognitiva y funcional entre personas con discapacidad intelectual preexistente, la entrevista al informante incluida en el CAMDEX-DS ha sido modificada para dar mayor importancia al deterioro observado, tomando como referencia el mejor nivel de funcionamiento previo de la persona.

El CAMDEX-DS se compone de distintas evaluaciones y de guías para el diagnóstico y para la intervención posterior. A continuación se incluye una descripción más detallada de cada una de las secciones.

2.1. Contenidos

El CAMDEX-DS está compuesto por tres contenidos:

- ❖ El inventario.
- ❖ La guía para el diagnóstico clínico.
- ❖ La guía para la intervención tras el diagnóstico.

En este apartado se explica con detalle la estructura interna y las características de cada uno de ellos.

2.1.1. El inventario CAMDEX-DS

El inventario CAMDEX-DS es un instrumento diagnóstico dividido en las siguientes secciones:

1. Una **entrevista estructurada con un informante** (familiar o cuidador) que proporcione información sobre el estado actual del paciente y de su historia médica.
2. Una **evaluación directa del paciente**. Consta de una breve entrevista clínica estructurada que recoge información sobre su estado de salud mental actual así como información adicional sobre los síntomas de demencia que presenta. También incluye una **breve batería neuropsicológica (CAMCOG-DS)** que permite valorar las funciones cognitivas que se ven afectadas en caso de demencia.

A continuación se incluye una descripción más detallada de cada una de las secciones del inventario CAMDEX-DS. Estas secciones vienen precedidas por el registro de la información general del paciente.

Sección 1. La entrevista al informante

Esta sección incluye una entrevista estructurada que se realiza con un familiar o con un cuidador que conozca bien al paciente, en ausencia del mismo. La entrevista debe ser cara a cara siempre que sea posible, aunque puede obtenerse información satisfactoria mediante una entrevista telefónica. El objetivo de esta entrevista es facilitar la recogida sistemática de información sobre los síntomas que presenta, así como de la historia clínica, con la finalidad de llegar a un diagnóstico diferencial. Debido al especial énfasis puesto en la importancia de los cambios observados con respecto al nivel de funcionamiento basal de la persona, la entrevista debe llevarse a cabo con un informante que conozca a la persona con síndrome de Down desde hace al menos 6 meses. La entrevista al informante tiene una duración aproximada de 40 minutos y comprende las siguientes cuatro partes:

Parte I. Mejor nivel de funcionamiento del paciente

Esta parte de la entrevista facilita la recopilación de la información sobre el mejor nivel de funcionamiento previo de la persona, incluyendo preguntas sobre educación y empleo, habilidades básicas y vida independiente.

Parte II. Deterioro cognitivo y funcional

Esta parte de la entrevista se centra en el deterioro de las áreas funcionales que se sabe que están afectadas en caso de demencia: las habilidades de la vida diaria, la memoria y la orientación, otras habilidades cognitivas, la personalidad, la conducta y el autocuidado.

Parte III. Estado de salud mental

Esta parte de la entrevista se centra en los problemas de salud mental. A la hora de realizar el diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta la presencia de estos problemas. En concreto, se evalúan la depresión, la ansiedad, el trastorno paranoide y el delirium.



Parte IV. Estado de salud física

Esta parte de la entrevista se centra en los problemas físicos que deben ser considerados al hacer un diagnóstico de demencia. Incluye la discapacidad física, el hipotiroidismo, los problemas cerebrovasculares y otras enfermedades orgánicas.

Sección 2. Evaluación del paciente

La segunda sección del programa comprende las evaluaciones realizadas directamente con el propio paciente. Incluye tanto el informe subjetivo como la medición objetiva del deterioro funcional asociado a la demencia o a otros trastornos mentales o físicos. La evaluación se compone de las siguientes tres partes:

Parte I. Entrevista clínica

Se trata de una breve entrevista con el paciente que incluye una historia clínica básica, el estado de salud mental actual del paciente y otra información adicional en relación con los síntomas de demencia que presenta.

Parte II. Examen cognitivo (CAMCOG-DS)

Esta breve batería neuropsicológica está basada en el CAMCOG, que fue diseñado para satisfacer la necesidad de evaluar todos los déficits cognitivos especificados en los criterios diagnósticos operativos para demencia como, por ejemplo, déficits mnésicos, afasia, apraxia, agnosia y alteración en el pensamiento (función ejecutiva). Los ítems dentro de cada dominio cognitivo están ordenados por dificultad para permitir una valoración a lo largo del rango completo de la habilidad cognitiva. El CAMCOG-DS incluye la evaluación de aquellos dominios que se sabe que se deterioran en caso de demencia: orientación, lenguaje (comprensión y expresión), memoria (nuevos aprendizajes, remota y reciente), atención, praxis (dibujo de figuras complejas y la capacidad para llevar a cabo tareas complejas), pensamiento abstracto y percepción.

El examen cognitivo CAMCOG-DS ofrece puntuaciones de subescalas de funciones hipotéticamente dissociables, así como una puntuación total con un máximo de 109 puntos. Cada ítem aporta entre 1 y 6 puntos a la subescala correspondiente así como a la puntuación total. La mayoría de los ítems incluidos en el CAMCOG-DS provienen directamente del CAMCOG. Aquellos ítems que se consideraron demasiado difíciles para muchas personas con discapacidad intelectual fueron modificados siempre que fue posible; en caso contrario, se reemplazaron por otros más fáciles procedentes del *Severe Impairment Battery* (Saxton et al., 1993) que evaluaban la misma área funcional. La versión revisada del CAMCOG (1998) incluye provisionalmente tests adicionales de función ejecutiva, que podrían ser utilizadas para calcular una puntuación independiente de la función ejecutiva. Estos no han sido incluidos en el CAMCOG-DS debido a su alto nivel de dificultad. Sin embargo, hay dos medidas incluidas en el CAMCOG-DS que pueden ser consideradas como medidas de la función ejecutiva: fluidez verbal y semejanzas. Las modificaciones realizadas en el CAMCOG-DS, en comparación con el CAMCOG original, hacen que sea más probable que las personas con discapacidad intelectual obtengan puntuaciones por encima de cero en los dominios individuales y en el global de la prueba, evitando así el denominado efecto suelo. Esto permite que cualquier pérdida funcional pueda ser detectada en cualquier momento.

Parte III. Observaciones del entrevistador

Consiste en un listado estandarizado de síntomas para registrar las observaciones sobre el estado mental actual, la apariencia y la conducta del paciente durante la evaluación.

2.1.2. Guía para el diagnóstico clínico

Esta guía se incluye como capítulo 4 en este mismo manual. Su propósito es proporcionar al profesional herramientas que le ayuden a llegar a un diagnóstico adecuado, descartando otras enfermedades o trastornos y relacionando los ítems del inventario con diversos criterios diagnósticos de demencia.

Sección 1. Diagnóstico diferencial y exámenes complementarios

En esta primera sección se incluyen los diagnósticos clave que deben ser considerados y un diagrama de flujo para ayudar en el proceso de diagnóstico diferencial. Se recomienda realizar exámenes médicos específicos como parte del proceso diagnóstico. El proceso diagnóstico de cualquier persona debe basarse en un juicio clínico informado basado en la observación clínica, por lo que esta lista es solo una herramienta complementaria en el proceso y no debe considerarse exhaustiva.

Sección 2. Resumen de los criterios diagnósticos

Los resúmenes estructurados de los criterios diagnósticos para demencia del CAMDEX, de la CIE-10 y del DSM-IV se presentan en forma de listado. La información obtenida mediante la entrevista al informante del CAMDEX-DS es utilizada para determinar si se cumplen los criterios de demencia y es complementada por los resultados del CAMCOG-DS.

2.1.3. Directrices para la intervención tras el diagnóstico

Estas directrices se incluyen en el capítulo 5 del manual con el fin de que una vez el diagnóstico de demencia se ha realizado, se pueda desarrollar un plan asistencial adaptado a la persona.

Sección 1. Guía resumen para la asistencia

Esta sección incluye una guía sobre las estrategias que deben seguir al diagnóstico de demencia en las personas con síndrome de Down y en aquellas con discapacidad intelectual de distinta etiología. El diagnóstico de demencia es el comienzo, no el fin, de una nueva estrategia de asistencia sanitaria y social.

Sección 2. Lista de control del entorno

En la segunda sección se adjunta un ejemplo de una lista de comprobación del entorno para hogares residenciales con el objetivo de ayudar a evaluar la idoneidad de la vivienda en el caso de personas con discapacidad intelectual que desarrollan demencia.



2.2. Materiales

El CAMDEX-DS está compuesto por los siguientes materiales:

- ❖ **Manual:** incluye la guía para el diagnóstico clínico y las directrices para la intervención tras el diagnóstico.
- ❖ **Cuadernillo de anotación:** contiene el inventario CAMDEX-DS y recoge las preguntas correspondientes a la entrevista del informante y a la evaluación del paciente (entrevista clínica y evaluación neuropsicológica CAMCOG-DS). Se deberán anotar en él todas las respuestas proporcionadas.
- ❖ **Cuaderno de estímulos:** incluye los estímulos visuales necesarios para la aplicación del CAMCOG-DS (con textos en castellano y en catalán para el evaluado).

2.3. Aplicación del inventario

2.3.1. Tiempo de aplicación

La entrevista con el informante puede durar unos 40 minutos. La sección dirigida a la entrevista directa con el evaluado tiene una duración que puede oscilar entre los 35 y los 60 minutos aproximadamente, en función del nivel de discapacidad intelectual.

2.3.2. Consideraciones especiales

Cuando se emplee la adaptación española en otros países de habla española, es aconsejable modificar los ítems 191, 192, 193, 194 y 216 (ver apartado 3.2.2) acomodándolos al entorno cultural propio, si bien conviene tener en cuenta:

- a) Que aludan a situaciones o personajes de características análogas (por su relevancia, profesión, significación histórica-cultural, etc.).
- b) Que se refieran a fechas o períodos temporales semejantes a los que aparecen en esta versión.

2.3.3. Normas de puntuación

Es muy importante anotar las respuestas a cada ítem en el transcurso de la entrevista. En los casos en que el paciente o el informante no puedan o no quieran dar una respuesta, o cuando un ítem no sea aplicable, deben anotarse los códigos correspondientes que se especifican en el cuadernillo de anotación al comienzo de cada sección.

Una vez que se ha aplicado el inventario, es necesario trasladar las puntuaciones de los ítems del CAMCOG-DS a la tabla de resumen que se encuentra en la página 30 del cuadernillo

de anotación. En ella aparecen los ítems que puntúan en cada dominio el examen cognitivo. Cada respuesta posible a cada ítem tiene un código asociado que aparece junto a su casilla de verificación. Este código es la puntuación en el ítem que se tendrá que anotar en la casilla correspondiente de la tabla resumen. Cada dominio cognitivo tiene una puntuación total que aparece destacada en la tabla y que es la suma de las puntuaciones de todos sus ítems. Finalmente, el profesional deberá sumar el total de todos los dominios para obtener la puntuación total en el CAMCOG-DS.

2.3.4. Normas de interpretación

Los estudios llevados a cabo para la adaptación española del CAMCOG-DS, permitieron establecer dos puntos de corte orientativos para la sospecha de deterioro cognitivo en el grupo de personas con SD en función del grado de DI:

- ❖ Grupo con SD con grado de DI leve: puntuación total = 68.
- ❖ Grupo con SD con grado de DI moderada: puntuación total = 52.

Por otro lado, la entrevista al informante CAMDEX-DS también permite al clínico extraer información de los cambios en la cognición y el comportamiento que pueden ser calificados en función de los conjuntos de criterios estándar utilizados para el diagnóstico de demencia (y sus subtipos) u otros trastornos mentales en la población general (CIE-10 y DSM-IV), tal y como se explica en el siguiente apartado.

2.4. Utilización del CAMDEX-DS para llegar a diagnósticos operativos

.....

2.4.1. Procedimientos diagnósticos

Cuando el CAMDEX-DS es aplicado por clínicos, se efectúa un diagnóstico clínico tras la finalización de la evaluación. Este diagnóstico clínico se basa en los criterios operativos definidos en el capítulo 4, "Guía para el diagnóstico clínico", y utiliza toda la información recogida con el instrumento. También es posible llegar al diagnóstico usando los criterios DSM-IV y CIE-10. Cada criterio diagnóstico conlleva un deterioro en una o varias áreas, que son evaluadas mediante distintos ítems de la entrevista CAMDEX-DS. Las respuestas a los ítems proporcionadas por el informante expresarán el nivel de deterioro del paciente en cada área, de manera que el profesional podrá determinar posteriormente si se cumplen los criterios para el diagnóstico de demencia y de demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, como se comentará posteriormente en este manual, en ocasiones será necesaria la realización de exámenes médicos complementarios que permitan descartar otras enfermedades o trastornos.

En este capítulo también se incluye una breve referencia para el diagnóstico diferencial de deterioro en la etapa de madurez.



2.4.2. Gravedad de la demencia

En el capítulo “Guía para el diagnóstico clínico” de este manual se detallan los criterios clínicos para valorar la gravedad de la demencia (leve, moderada y severa). Estos criterios, además de incluir el deterioro de la función cognitiva, tienen en cuenta los cambios en las actividades diarias y de la personalidad.

3

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CAMDEX-DS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA



En este capítulo se detallan los datos del estudio de adaptación y validación del CAMDEX-DS en población española llevado a cabo por S. Esteba-Castillo, A. Dalmau-Bueno, N. Ribas i Vidal, M. Vilà i Alsina y R. Novell i Alsina entre los años 2009 y 2011 (Esteba-Castillo *et al.*, 2013).

3.1. Introducción

El síndrome de Down (SD) está causado por anomalías en un segmento del cromosoma 21, en concreto una trisomía, el cariotipo más común que explica el 95% de los casos que presentan este síndrome. La incidencia de esta enfermedad se estima en 1 de cada 650-1.000 nacimientos (Bittles *et al.*, 2007). La discapacidad intelectual (DI) es el rasgo más sobresaliente del SD con un fenotipo cognitivo asociado y un perfil neuropsicológico específico (Edgin *et al.*, 2010; Lanfranchi *et al.*, 2010; Fidler y Nadel, 2007). La gran mayoría de las personas con SD presentan niveles de deterioro intelectual que varían de leves a severos (Silverman, 2007) y se estima que el cociente intelectual (CI) de las personas con este síndrome suele estar dentro de un rango comprendido entre 30 y 70 (Vicari *et al.*, 2005). Las personas con SD muestran una disociación en sus habilidades para el lenguaje, mostrando más dificultades en el expresivo que en el receptivo (Silverman, 2007), especialmente en lo que refiere a la sintaxis y a la producción del habla (Roberts *et al.*, 2007). Estudios recientes han mostrado cómo la dificultad para procesar y retener las representaciones fonológicas de las palabras está relacionada también con defectos en la memoria de trabajo (Fernández, 2012). Los déficits de aprendizaje de las personas con SD presentan una disociación, con dificultades en la memoria explícita que se contraponen a la buena capacidad de memoria implícita mantenida por procesos más automáticos (Vicari *et al.*, 2005). Se ha demostrado que en el SD existe también un déficit de atención junto con dificultades en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas (Krinsky-McHale *et al.*, 2008). De hecho, son numerosos los estudios que muestran cierto patrón disejecutivo cuando se compara con otros tipos de DI de distinta etiología (Lanfranchi *et al.*, 2010; Rhodes *et al.*, 2010), especialmente en la capacidad de reversibilidad mental y en la memoria de trabajo, de forma que el grupo de personas con SD tienen preservadas la capacidad de inhibición y las tareas de fluencia verbal (Carney *et al.*, 2013).

Al déficit intelectual causado por la sobreexpresión del cromosoma 21 se une una neurodegeneración de tipo Alzheimer que es dependiente de la edad. Así, entre los 30 y los 39

años, estas personas presentan tasas de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) bajas, pero que se incrementan hasta el 10-25% entre los 40 y los 49 años, hasta un 20-50% en la década de los 50 y, por último, hasta un 30-75% a partir de los 60 años (Holland *et al.*, 1998; Lai y Williams, 1989; Wisniewski *et al.*, 1985).

El estudio de los déficits cognitivos subyacentes a la población con SD puede ayudar a entender qué está determinado por el propio síndrome y qué está determinado por la manifestación del inicio de una enfermedad neurodegenerativa como la EA. Sin embargo, este grupo de población presenta dos rasgos que todo profesional debe considerar en la práctica clínica cuando se plantea explorar la posible presencia de demencia.

En primer lugar, nos encontramos ante un grupo que puede presentar un tipo de demencia diferente a la EA típica observada en la población general, con cambios tempranos más evidentes en la personalidad y en la conducta que en la memoria (Ball *et al.*, 2006a). En principio se pensó que este hecho se debía a la presencia de una distribución distinta de placas seniles entre la población normal y la población con SD. Sin embargo, al igual que en la población general, las áreas cerebrales más afectadas en los pacientes con SD y EA son la amígdala, el hipocampo y las áreas de asociación del lóbulo frontal, temporal y parietal (Mann *et al.*, 1986). Al igual que en la población general, la deposición de la proteína beta-amiloide/A4 representa el cambio patológico más temprano que acontece entre la segunda y la tercera década de la vida en las personas con SD (Mann, 1989). Tras este cambio, hacia la cuarta o quinta década, aparecen ovillos neurofibrilares que conducen a la muerte neuronal y a la atrofia cerebral (Mann *et al.*, 1990). Si bien la distribución neuropatológica es la misma, se sugiere que la deposición de proteína beta-amiloide se concentraría de forma temprana en el lóbulo frontal, lo que explicaría una presentación clínica distinta en esta población. Otra explicación más convincente y que no estaría en discordancia con la propuesta por este autor, la encontramos en el desarrollo cerebral de las personas con SD. Esta población presenta un lóbulo frontal menos desarrollado, por lo que es plausible pensar que la capacidad de reserva en esta área en concreto sea menor y, en consecuencia, sería la primera en presentar déficits ante la pérdida neuronal típica de una enfermedad neurodegenerativa.

En segundo lugar, este grupo presenta déficits intelectuales previos que pueden confundir el diagnóstico clínico si no se cuenta con los instrumentos de medida adecuados. Existe un vacío significativo en la generación y validación de instrumentos en lengua española que tengan en cuenta las características intrínsecas de este colectivo y que cuenten con las propiedades psicométricas adecuadas. La mayoría de las pruebas cognitivas que se utilizan en la práctica clínica miden valores de inteligencia general, sin aportar un perfil que describa las distintas funciones cognitivas de la persona. En los entornos clínicos habituales se están utilizando tests cognitivos como el *Mini Mental State Examination* (MMSE, Folstein *et al.*, 1975) o la *Wechsler Adult Intelligence Scale* (WAIS, Wechsler, 1958), que no solo presentan unas características psicométricas poco sensibles e inespecíficas para este colectivo, sino que además están muy sesgadas por el lenguaje (Haxby, 1989). Todo ello no solo dificulta un diagnóstico adecuado, sino también limita el beneficio de una intervención temprana adecuada.

A mediados del 2006, se publicó el CAMDEX-DS (*Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with Down's Syndrome and Others with Intellectual Disabilities*, Ball *et al.*, 2006b), que es el único test cognitivo existente en el mercado dirigido a la detección de demencia en



personas con SD y otras causas de DI, diferenciando entre el déficit cognitivo secundario a la propia DI y el déficit cognitivo secundario a un proceso degenerativo. El objetivo del presente trabajo es la adaptación y validación del CAMDEX-DS en población castellanoparlante con DI.

3.2. Material y métodos

3.2.1. Sujetos

Se realizó un estudio de validación llevado a cabo mediante un diseño de tipo observacional, transversal y multicéntrico realizado en tres fases. Con el objetivo de asegurar la distribución geográfica de la muestra, el estudio contaba con muestras de varias autonomías españolas de las zonas norte, sur, centro y este. La primera fase consistió en la preparación del material, la selección de los centros asistenciales a nivel estatal, la formación de los psicólogos responsables de la aplicación de las pruebas y la inclusión de los pacientes. La segunda fase supuso una continuación del periodo de inclusión de participantes en el estudio y la exploración propiamente dicha, mientras que en la tercera se realizó el procesamiento de los datos y el análisis de los resultados. Se incluyeron un total de 146 adultos con DI de grado leve o moderado. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 30 y los 75 años que presentaran una DI clasificada como leve o moderada. Además debían contar con la presencia de un responsable, tutor o familiar que representase legalmente al paciente y que firmara el consentimiento informado en caso de que este estuviera incapacitado. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: déficit intelectual grave o severo, ausencia de consentimiento informado y limitaciones sensoriales severas que impidieran llevar a cabo la exploración de forma adecuada.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Institut d'Assistència Sanitària (CEIC-IAS, S-041-813) de Salt (Girona). Para cada uno de los centros se realizó un convenio de colaboración en el marco del estudio de validación del CAMDEX-DS teniendo en cuenta la declaración de Helsinki (2000), las Normas de las Buenas Prácticas Clínicas y la legislación vigente (catalana y española) en lo que a investigación clínica se refiere. Los investigadores se comprometieron a seguir el Código de Buenas Prácticas científicas desarrollado por el Instituto Municipal de Investigación Médica y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Todos los evaluados, así como sus tutores legales, otorgaron su consentimiento informado por escrito.

La identidad de las personas no figuró en el cuaderno de recogida de datos (CRD) y se utilizaron códigos personales formados por las iniciales y el número de inclusión para la identificación de los pacientes. Se realizó un proceso de auditoría aleatorizada entre el 10-15% de los casos incluidos en el CRD con el fin de garantizar la calidad de los mismos.

3.2.2. Instrumentos

Las evaluaciones se llevaron a cabo de forma independiente por cada uno de los psicólogos de los distintos centros participantes. Dichos psicólogos habían sido previamente entrenados con el objetivo de asegurar la unicidad en la aplicación del protocolo del estudio. Se aplicaron las pruebas que se describen a continuación.

Dementia Questionnaire for Persons with Mental Retardation (DMR, Evenhuis, 1992b)

Se trata del instrumento más reconocido para la evaluación de la demencia en adultos con DI. Es una herramienta de *screening* para la sospecha de deterioro cognitivo a partir de la cual se recomienda un estudio exhaustivo. Está formado por un total de 50 ítems. Estos ítems se agrupan en ocho escalas: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, orientación temporo-espacial, habla, motricidad, humor, actividades e intereses y alteraciones conductuales. De la suma de estas escalas, se obtienen dos índices que se calculan por separado: un índice cognitivo (SCS, suma de las escalas de memoria a corto y a largo plazo y orientación temporo-espacial) y un índice social (SOS, suma de las escalas de habla, motricidad, actividades e intereses y alteraciones conductuales). Son numerosas las investigaciones que utilizan el DMR como instrumento de *screening* para la detección de demencia en ensayos clínicos (Boada-Rovira *et al.*, 2005; Prasher *et al.*; Prasher *et al.*, 2005).

Evenhuis reportó una sensibilidad del DMR del 100% para la identificación de demencia y sugirió unos puntos de corte indicativos de deterioro cognitivo (Evenhuis, 1992a). Prasher realizó una evaluación de 100 personas con SD sugiriendo modificaciones de los puntos de corte para la población con SD. Asimismo, se ha mostrado como una herramienta sensible a los cambios de los síntomas de la demencia a lo largo del tiempo (Prasher, 1997).

Los puntos de corte de cada índice se establecen en función de nivel de DI. Se determina que el *screening* es positivo para demencia cuando los resultados obtenidos se sitúan por encima del punto de corte en una de las escalas SCS y SOS (ver tabla 3.1).

Tabla 3.1. Criterios de demencia DMR modificados para el SD

Criterios de gravedad	SCS	SOS
DI leve (CI 50-69)	≥ 7	≥ 10
DI moderada (CI 35-49)	≥ 25	≥ 15
DI grave (CI 20-34)	≥ 34	≥ 15

Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT, Kaufman y Kaufman, 2004)

Es un test diseñado para evaluar la inteligencia verbal y no verbal en niños, adolescentes y adultos que cuenta con una adaptación española^(*). Está constituido por dos subtests que miden la inteligencia cristalizada (Información verbal, conocimiento del significado de palabras) y la inteligencia fluida (Matrices, es decir, habilidad para percibir relaciones y completar analogías). Los ítems del subtest Matrices contienen dibujos reales o abstractos, lo que facilita su aplicación a personas con dificultades del lenguaje. Con la suma de las puntuaciones de ambos tests se obtiene

(*) Otras pruebas disponibles para evaluar la inteligencia en niños, adolescentes y adultos son las Escalas de Inteligencia de Reynolds (RIAS) y el Test de Inteligencia Breve de Reynolds (RIST) (Reynolds y Kamphaus, 2013) o el MATRICES, Test de Inteligencia General (Sánchez-Sánchez y Santamaría, 2014).



un Índice de inteligencia. La consistencia interna es de 0,93 para el subtest Vocabulario, de 0,88 para el subtest Matrices y de 0,94 para el Índice de inteligencia total.

The Cambridge Examination for Mental Disorders of Older people with Down's Syndrome and Others with Intellectual Disabilities (CAMDEX-DS, Ball et al., 2006)

EL CAMDEX-DS es un instrumento diagnóstico para la detección de demencia en personas con SD y otras causas de DI. El CAMDEX fue desarrollado originariamente en 1986 como una herramienta estandarizada para el diagnóstico del deterioro cognitivo en la población general y fue publicado por primera vez en 1988 (Roth *et al.*, 1988). En 1998 apareció una nueva versión revisada (CAMDEX-R) (Roth *et al.*, 1998; versión española, 2003). La sensibilidad y la especificidad del CAMDEX-DS para el diagnóstico de demencia en población con DI de habla inglesa son de 0,88 y 0,94, respectivamente.

Para la preparación de la versión española de CAMDEX-DS se realizó un proceso de traducción directa e inversa (*back-translation*) a cargo de un lingüista de habla inglesa y con formación en Psicología que tuvo en cuenta la especificidad cultural española a la hora de realizar la adaptación transcultural.

En la versión española del CAMDEX-DS se han adaptado los ítems del 191 al 194 que en la versión original hacían referencia a John Lennon, a la princesa Diana de Gales, al nombre de la reina de Inglaterra y al del primer ministro.

También se han sustituido las dos imágenes del ítem 216 por las del Rey de España (D. Juan Carlos de Brobón) y la del Papa Francisco.

3.2.3. Procedimiento y recogida de datos

Se llevó a cabo un muestreo consecutivo sin aleatorización de todos los usuarios que cumplieran los criterios de inclusión. A cada uno de los participantes se les aplicó el K-BIT, el DMR y el CAMDEX-DS. Para evitar los posibles sesgos derivados del deterioro cognitivo según el nivel de discapacidad intelectual, se estableció que no podían observarse cambios de categorías en el K-BIT en comparación con la puntuación del último año. El diagnóstico clínico probable de demencia se realizó atendiendo a los criterios del DSM-IV y de la CIE-10.

Entre la muestra total de participantes se escogió una muestra aleatoria para la realización de los estudios de test-retest una vez transcurridas 3 semanas desde la primera aplicación.

3.2.4. Análisis estadísticos

El tamaño de la muestra se determinó en función de la precisión que se deseaba alcanzar con el coeficiente de concordancia Kappa entre el diagnóstico según el CAMDEX-DS y el diagnóstico según criterios clínicos. Se estableció una muestra inicial de 92 sujetos para un coeficiente de concordancia de 0,70 con una proporción de clasificaciones positivas del 40% según criterios del CAMDEX-DS y una proporción de clasificaciones positivas del 30% de acuerdo con los criterios clínicos, con una precisión de 0,15 y un intervalo de confianza del 95%. Asumiendo una mortalidad experimental del 10% se estableció que sería necesario reclutar una muestra total de 100 pacientes.

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables del estudio utilizando técnicas de análisis de datos cuantitativos (medidas de tendencia central y dispersión) y cualitativos (medidas de frecuencia absoluta y relativa), presentando datos generales y estratificados según etiología y grado de DI.

Para determinar la fiabilidad test-retest se calculó el coeficiente Kappa para la clasificación del CAMDEX-DS en el momento basal y a las tres semanas en 30 participantes. Para determinar la fiabilidad entre evaluadores se calculó el coeficiente Kappa para establecer la concurrencia entre examinadores para la clasificación del CAMDEX-DS. Para determinar la fiabilidad con el diagnóstico clínico se calculó el coeficiente Kappa entre la clasificación realizada por el CAMDEX-DS y los criterios del DSM-IV y de la CIE-10. Se determinó asimismo la fiabilidad del test mediante el estadístico alfa de Cronbach (límite inferior aceptable: 0,70) así como las correlaciones ítem-total (límite inferior aceptable: 0,30, de acuerdo a Kline, 1993). Se estratificó la muestra según la etiología de la DI, es decir, el grupo de participantes con síndrome de Down y el grupo de etiología desconocida. Para cada uno de los grupos se describieron las dimensiones del CAMCOG-DS según el grado de DI. Se estudiaron diferencias entre ambos grupos. Finalmente se calculó la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo del CAMCOG-DS en función del grado de DI.

Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con un nivel de confianza del 95%, con pruebas tanto paramétricas como no paramétricas atendiendo a la distribución de los datos.

3.2.5. Descripción de la muestra

De las 146 personas que participaron en el estudio el 60,95% (n = 89) eran varones y el 39,05% (n = 51), mujeres. El 57,54% (n = 84) presentaban un nivel de DI moderado y el 42,46% (n = 62), una DI leve. En el estudio de las características de los participantes según el nivel de DI, se observaron diferencias estadísticamente significativas en función de la etiología ($p < 0,001$), siendo el grupo de personas con SD los que presentaban una mayor proporción de DI moderada. No se observaron diferencias significativas en función del sexo, como se puede observar en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas de la muestra total (n = 146)

		Nivel de discapacidad intelectual (DI)				Total	
		DI leve		DI moderada			
		n	%	n	%	n	%
Sexo	Varones	41	46,06	48	53,94	89	100
	Mujeres	21	41,17	30	58,83	51	100
Etiología	Síndrome de Down	36	34,95	67	65,05	103	100
	Otras etiologías	26	60,47	17	39,53	43	100
Total		62	42,46	84	57,54	146	100



El grado de cumplimentación del CAMCOG-DS fue del 97% en los casos de personas con DI leve y del 95% en los casos de DI moderada. En el caso de la entrevista del CAMDEX-DS, en ambos grupos fue del 99%.

3.3. Propiedades psicométricas

3.3.1. *Fiabilidad del CAMDEX-DS*

Para estimar la fiabilidad test-retest del CAMDEX-DS se calculó el coeficiente Kappa para la clasificación del test en el momento basal y a las tres semanas en 30 participantes. Se obtuvo un valor Kappa de 0,92 con una significación de $p < 0,01$.

Respecto a la fiabilidad interjueces, el análisis individual de cada uno de los ítems mostró una concordancia alta con un índice Kappa de 0,91 y una significación $p < 0,001$.

3.3.2. *Concordancia con los criterios diagnósticos*

En el análisis de concordancia mediante el índice Kappa entre los criterios clínicos del DSM-IV y de la CIE-10 y el CAMDEX-DS se observaron unas muy buenas concordancias con valores cercanos a la unidad, incluso estratificando según el grado de DI. La concordancia entre los criterios del CAMDEX-DS y los del DSM-IV arrojó un valor Kappa de 0,95 ($p < 0,001$) y la concordancia entre los criterios del CAMDEX-DS y los de la CIE-10 fue de 0,97 ($p < 0,001$).

3.3.3. *Consistencia interna del CAMCOG-DS*

En el análisis de las propiedades psicométricas del CAMCOG-DS se obtuvieron buenos resultados de consistencia interna, dado que el alfa de Cronbach alcanzó un coeficiente de 0,94 en todas las dimensiones y en la escala total. Como se puede observar en la tabla 3.3, todas las correlaciones ítem-test se situaron por encima de 0,30 y el rango de variación estaba entre 0,31 y 0,69. Las mayores correlaciones ítem-test se obtuvieron en las siguientes variables: fluencia verbal (animales en un minuto; 0,69), praxis ideatoria (coger el papel con la mano derecha, doblarlo por la mitad y tirarlo al suelo; 0,66) y atención (contar los dedos de la mano; 0,66). En cambio, las correlaciones más bajas se obtuvieron en denominación (denominación de objetos reales) y praxis constructiva gráfica (reproducción de un cuadrado), ambas con un valor de 0,31.

Tabla 3.3. Consistencia interna

Dimensión	Ítem	Descripción	Correlación ítem-test	Correlación inter-ítem media
ORIENTACIÓN	Orientación_1	Nombre	0,36	0,25
	Orientación_2	Día	0,44	0,25
	Orientación_3	Mes	0,65	0,25
	Orientación_4	Año	0,63	0,25
	Orientación_5	Dirección	0,50	0,25
	Orientación_6	Ciudad	0,58	0,25
LENGUAJE	Leng_comprensivo_1	Mover	0,39	0,25
	Leng_comprensivo_2	Oreja	0,57	0,25
	Leng_comprensivo_3	Techo	0,49	0,25
	Leng_comprensivo_4	Hombro	0,58	0,25
	Leng_comprensivo_5	Ojos	0,65	0,25
	Leng_comprensivo_6	Mano	0,66	0,25
	Leng_expresivo_1	Objetos	0,31	0,25
	Leng_expresivo_2	Imágenes	0,58	0,25
	Leng_expresivo_3	Fluidez	0,70	0,25
	Leng_expresivo_4	Martillo	0,34	0,25
	Leng_expresivo_5	Farmacia	0,47	0,25
	Leng_expresivo_6	Puente	0,51	0,25
	Leng_expresivo_7	Repetición	0,59	0,25
MEMORIA	Memoria_aprendizaje_1	Recordar imágenes	0,60	0,25
	Memoria_aprendizaje_2	Reconocimiento	0,66	0,25
	Memoria_aprendizaje_3	Codificar nombre	0,51	0,25
	Memoria_aprendizaje_4	Codificar dirección	0,52	0,25
	Memoria_aprendizaje_5	Recordar nombre	0,45	0,25
	Memoria_aprendizaje_6	Recordar dirección	0,60	0,25
	Memoria_remota_1	Lola Flores	0,57	0,25
	Memoria_remota_2	Barcelona	0,45	0,25
	Memoria_reciente_1	Presidente	0,66	0,25
	Memoria_reciente_2	Rey	0,60	0,25



Tabla 3.3. Consistencia interna (continuación)

Dimensión	Ítem	Descripción	Correlación ítem-test	Correlación inter-ítem media
ATENCIÓN	Atención_1	Veinte	0,65	0,25
	Atención_2	Dedos	0,66	0,25
	Atención_3	Span de dígitos	0,61	0,25
PRAXIS	Dibujar_copiar_1	Círculo	0,31	0,27
	Dibujar_copiar_2	Cuadrado	0,55	0,25
	Dibujar_copiar_3	Casa	0,67	0,25
	Dibujar_copiar_4	Reloj	0,68	0,25
	Acción_motora_1	Adiós	0,34	0,25
	Acción_motora_2	Cuchillo	0,40	0,25
	Acción_motora_3	Cepillo de dientes	0,44	0,25
	Acción_motora_4	Papel	0,66	0,25
	Acción_motora_5	Sobre	0,32	0,25
PENSAMIENTO ABSTRACTO	Abstracto_1	Frutas	0,58	0,25
	Abstracto_2	Ropa	0,59	0,25
	Abstracto_3	Muebles	0,51	0,25
PERCEPCIÓN	Percepción_1	Gente	0,35	0,25
	Percepción_2	Ángulos inusuales	0,52	0,25

3.3.4. Puntuaciones en el CAMCOG-DS de pacientes con etiología de SD

Se realizó el análisis de las puntuaciones obtenidas en el CAMCOG-DS en cada dimensión en personas con SD y divididas según su nivel de DI. La puntuación media del CAMCOG-DS del grupo de personas con SD y DI leve fue de 75,89 (Dt = 15,96) mientras que en el grupo con DI moderada la puntuación media fue de 57,09 (Dt = 17,63). Como se muestra en la tabla 3.4, las diferencias entre ambos grupos fueron estadísticamente significativas en la mayoría de dimensiones, con mayores puntuaciones medias en el grupo con DI leve ($p < 0,001$). La única dimensión en la que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos fue Percepción (que abarca el reconocimiento de personajes famosos y de objetos desde ángulos inusuales). Se calculó

el tamaño del efecto (d de Cohen) de estas diferencias. Cohen (1988) propuso rangos de valores para cada valor de la d de Cohen:

- ❖ d de Cohen $<0,20 \rightarrow$ efecto insignificante
- ❖ d de Cohen $>0,20 \rightarrow$ efecto pequeño
- ❖ d de Cohen $>0,50 \rightarrow$ efecto moderado
- ❖ d de Cohen $>0,80 \rightarrow$ efecto grande

Por ello se puede observar que el tamaño del efecto fue grande en todos los casos salvo en la dimensión Percepción.

Tabla 3.4. Estadísticos descriptivos de las dimensiones del CAMCOG-DS en pacientes con SD

Puntuación CAMCOG-DS	DI Leve					DI Moderada					Signifi- cación	d de Cohen
	n	Mínimo	Máximo	Media	Dt	n	Mínimo	Máximo	Media	Dt		
Orientación	35	1	12	10,26	2,54	64	2	12	7,33	2,86	$p < 0,001$	1,08
Lenguaje	35	8	26	19,31	4,24	64	5	25	16,09	4,10	$p < 0,001$	0,77
Memoria	35	6	28	18,77	5,71	64	0	24	13,33	5,65	$p < 0,001$	0,96
Atención	35	3	9	7,71	1,23	64	0	9	5,53	2,40	$p < 0,001$	1,14
Praxis	35	4	17	12,06	2,98	64	1	17	9,27	3,52	$p < 0,001$	0,86
Pens. abstracto	35	0	6	3,37	2,20	64	0	6	1,48	1,70	$p < 0,001$	0,96
Percepción	35	1	8	4,40	1,63	64	1	8	4,06	1,59	n.s.	0,21
Total	35	28	99	75,89	15,96	64	9	93	57,09	17,79	$p < 0,001$	1,11

3.3.5. Puntuaciones en el CAMCOG-DS de pacientes con DI de otras etiologías (no SD)

El análisis de las puntuaciones obtenidas en el CAMCOG-DS por el grupo de pacientes con etiología distinta al SD mostró diferencias estadísticamente significativas en la puntuación total con una media de 81,19 ($Dt = 16,61$) en el grupo con DI leve y de 67,82 ($Dt = 14,43$) en el grupo con DI moderada. También fueron estadísticamente significativas las diferencias en las dimensiones Orientación ($p < 0,01$), Lenguaje ($p < 0,05$), Atención ($p < 0,05$) y Percepción ($p < 0,05$). El tamaño del efecto (d de Cohen) de las diferencias se puede considerar entre medio y grande en todos los casos. En la tabla 3.5 se incluyen los estadísticos descriptivos de las dimensiones del CAMCOG-DS en los evaluados con etiologías distintas al síndrome de Down.



Tabla 3.5. Estadísticos descriptivos de las dimensiones del CAMCOG-DS en pacientes con DI de etiología diferente al SD

Puntuación CAMCOG-DS	DI Leve					DI Moderada					Significación	d de Cohen
	n	Mínimo	Máximo	Media	Dt	n	Mínimo	Máximo	Media	Dt		
Orientación	26	3	12	10,58	2,14	17	5	12	8,24	2,22	$p < 0,01$	1,07
Lenguaje	26	13	27	21,77	3,83	17	12	25	18,71	3,74	$p < 0,05$	0,81
Memoria	26	6	27	19,54	5,11	17	7	26	16,94	5,21	n.s.	0,50
Atención	26	3	9	7,62	1,72	17	2	9	6,29	2,44	$p < 0,05$	0,63
Praxis	26	5	18	12,50	3,33	17	3	17	10,65	3,33	n.s.	0,56
Pens. abstracto	26	0	6	3,38	1,92	17	0	4	2,29	1,45	n.s.	0,64
Percepción	26	2	8	5,81	1,67	17	2	8	4,71	1,53	$p < 0,05$	0,69
Total	26	37	103	81,19	16,61	17	40	92	67,82	14,43	$p < 0,01$	0,86

3.3.6. Estudio de la sensibilidad y la especificidad

Se realizó el análisis de los valores de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos entre el diagnóstico del CAMDEX-DS y las puntuaciones obtenidas en el CAMCOG-DS. En el grupo de personas con SD y DI leve se estableció un punto de corte de 68 (en la puntuación total), con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 80,94%, un valor predictivo positivo del 50% y un valor predictivo negativo del 93,80%. Por otra parte, como se muestra en la tabla 3.6, en la muestra de personas con SD y DI moderada se obtuvieron valores ligeramente superiores con una sensibilidad del 84,60%, una especificidad del 81,14%, un valor predictivo positivo del 57,89% y un valor predictivo negativo del 93,10% para el punto de corte de 52.

Tabla 3.6. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del CAMCOG-DS respecto del grado de DI establecido por la entrevista del CAMDEX-DS en personas con SD

	Grado de DI	Punto de corte CAMCOG-DS	Sensibilidad	Especificidad	Valor predictivo positivo	Valor predictivo negativo
Diagnóstico CAMDEX-DS	DI leve	60	40,00%	89,21%	40,00%	84,21%
		64	60,00%	86,21%	50,00%	88,80%
		68	80,00%	80,94%	50,00%	93,75%
		72	80,00%	78,42%	40,00%	92,85%
	DI moderada	40	53,84%	94,28%	77,77%	84,61%
		44	69,23%	92,42%	75,00%	88,80%
		48	76,92%	87,71%	66,60%	90,90%
		52	84,61%	81,14%	57,89%	93,10%

3.4. Discusión

El CAMDEX-DS es una prueba con alta aplicabilidad que se puede utilizar con personas con DI leve y moderada independientemente de la etiología de la discapacidad intelectual. Existe una buena concordancia entre el diagnóstico basal y el realizado a los 21 días, siempre y cuando no se produzcan cambios clínicos relevantes por causas orgánicas o de índole ecológica. Por otra parte, se observa una alta concordancia entre examinadores en relación al diagnóstico del CAMDEX-DS. En los análisis psicométricos llevados a cabo en relación a la consistencia interna, se obtienen buenos resultados en el alfa de Cronbach así como correlaciones elevadas entre los ítems y la puntuación total.

Las puntuaciones obtenidas en el CAMCOG-DS por personas con SD son superiores en el grupo de DI leve, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en todas las dimensiones a excepción de Percepción, lo cual refuerza la capacidad discriminativa del CAMCOG-DS según el nivel de DI.

El CAMCOG-DS permite establecer dos puntos de corte para la sospecha de deterioro cognitivo en el grupo de personas con SD en función del grado de DI. Para el grupo SD con grado de DI leve se establece el punto de corte en una **puntuación total de 68** (sensibilidad = 80% y especificidad = 81%) y en una **puntuación total de 52** para el grupo SD con nivel de DI moderada (sensibilidad = 85%, especificidad = 81%).

Por otra parte, en el grupo de personas con DI de etiología desconocida, la amplia variabilidad de perfiles cognitivos hallados dificulta el hecho de establecer puntos de corte para la sospecha de deterioro cognitivo. Será el estudio longitudinal del perfil cognitivo del CAMCOG-DS y de la puntuación global lo que determinará la presencia o no de deterioro cognitivo.



Se considera importante señalar que las altas correlaciones obtenidas entre los criterios clínicos del CAMDEX-DS, el DSM-IV y la CIE-10 se debe al hecho de que comparten la mayoría de ítems que forman parte de cada uno de los criterios clínicos para el diagnóstico de demencia.

Por último, cabe señalar la importancia de dar a conocer este instrumento de valoración como base para el diagnóstico de EA en personas con y sin SD y, consecuentemente, la instauración de un tratamiento que permita frenar el avance de la enfermedad, la adecuación del entorno del paciente, la previsión del futuro y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida de las personas afectas de enfermedad de Alzheimer con o sin síndrome de Down y la de sus familias.

Limitaciones y prospectiva

Si bien se ha observado que los resultados de sensibilidad y especificidad entre el CAMCOG-DS y el CAMDEX-DS son buenos, con valores de sensibilidad y especificidad superiores al 80%, es importante recordar que las puntuaciones obtenidas en el CAMCOG-DS sirven para establecer una línea basal que contemple la evolución de la persona con DI. Los puntos de corte son orientativos.

4

GUÍA PARA EL
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

4.1. SECCIÓN 1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Guía para el diagnóstico diferencial del deterioro observado en personas con SD u otra discapacidad intelectual en la etapa de madurez

El CAMDEX-DS ha sido diseñado específicamente para ayudar al diagnóstico de demencia en aquellas personas con síndrome de Down. Llegar a dicho diagnóstico requiere de una evaluación completa en la que se descarte la presencia de otras posibles enfermedades o trastornos que pueden presentarse con una sintomatología similar a la demencia. Muchos de estos trastornos se pueden tratar y tienen un pronóstico muy diferente al de la demencia. Las investigaciones sobre la relación entre el SD y la demencia también requieren de un nivel similar de rigurosidad diagnóstica. Este proceso de diagnóstico tiene esencialmente tres etapas, cada una de las cuales está cubierta en el CAMDEX-DS por una o más secciones. Son las siguientes:

1. Una historia clínica sistemática obtenida de la propia persona y de un informante que le conozca bien para establecer la presentación y la evolución del problema (entrevista al informante y al paciente del CAMDEX-DS).
2. Un examen del estado físico y mental y una evaluación cognitiva (CAMCOG-DS), además de otros exámenes que permitan la evaluación del funcionamiento actual y la identificación de otras posibles causas de deterioro. Los exámenes médicos deberían estar dirigidos por el cuadro clínico, pero siempre deberían incluir exploraciones del estado físico básico de la persona (p. ej., función renal y hepática y la existencia o no de anemia) así como pruebas específicas como las medidas de la función tiroidea o la valoración por parte de especialistas de la audición o de la visión. Cuando el cuadro clínico es poco común o el diagnóstico está en duda, podría ser recomendable realizar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética cerebral (RM).
3. Una formulación detallada y una evaluación de los resultados en relación con los criterios de demencia y de otros trastornos físicos y mentales con el objetivo de llegar a un diagnóstico

definitivo. En concreto, en el caso de las personas con SD existen tres trastornos que son comunes y que su presencia podría tanto enmascarar la demencia como coexistir con ella y, de este modo, hacer que las discapacidades asociadas con el desarrollo de la demencia sean significativamente más pronunciadas. Estos son:

- a. Depresión.
- b. Hipotiroidismo.
- c. Disfunciones visuales o auditivas.

4. El proceso diagnóstico conduce a una formulación que reúne información de diversas evaluaciones y exploraciones y que finalmente determina la causa más probable de los cambios clínicos observados y los sitúa en el contexto de la persona. Así, esta es la base para desarrollar un plan de asistencia individualizada, teniendo en cuenta el diagnóstico y el conocimiento de la persona y de su entorno.

En la figura 4.1 se presenta un diagrama que puede guiar al profesional durante el proceso de diagnóstico diferencial.

4.2. SECCIÓN 2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA

Criterios diagnósticos de demencia reconocidos y los ítems del CAMDEX-DS que se relacionan con ellos

A continuación se presentan los criterios del CAMDEX-DS, del DSM IV y de la CIE-10 para el diagnóstico de demencia. Cada conjunto de criterios adopta la forma de un listado sistemático (*checklist*). Estos listados se incluyen como ayuda para resumir la información obtenida con el CAMDEX-DS, ya que se relaciona directamente con cada criterio. En cada uno de los criterios diagnósticos se incluyen los números de las preguntas de la entrevista al informante pertinentes y también es posible señalar el grado de deterioro observado en cada área. Así, el juicio puede ser realizado en función de si cada criterio se cumple o no, y el diagnóstico se puede realizar a partir de esta información junto con la obtenida en los exámenes físicos y mentales, la evaluación cognitiva (CAMCOG-DS) y otras valoraciones descritas anteriormente.

En esta sección también se incluyen las pautas para clasificar la demencia de acuerdo a la severidad clínica. Los perfiles se han incluido como guía para la gradación de la demencia.

**LA VISUALIZACIÓN
DE ESTAS PÁGINAS
NO ESTÁ DISPONIBLE.**

Si desea obtener más información
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



4.2.1. CAMDEX-R. CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA Y DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA

En el caso de las demencias, básicamente existe un deterioro global de la capacidad intelectual, emocional, motivacional y de la conducta en general del paciente, sin afectación de su nivel de conciencia a lo largo de un período de tiempo de 6 meses como mínimo. En los estadios iniciales algunas de las funciones especificadas pueden permanecer relativamente intactas.

Criterios de inclusión

Deberán cumplirse los criterios A, B y C.

A	HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA
	Disminución progresiva del rendimiento en el trabajo y en las actividades de la vida diaria no debida a problemas de salud o impedimentos físicos. Deterioro general de los procesos mentales manifestado como dificultad o pérdida en: ❖ Las habilidades necesarias para llevar a cabo actividades habituales en el trabajo, en el taller ocupacional o en el centro de día. ❖ La habilidad para el manejo de utensilios domésticos y de herramientas.

Área de deterioro	Pregunta	Deterioro leve	Deterioro grave
Actividades diarias habituales	33 Actividades diarias cotidianas en el trabajo, la escuela, el centro de día	↓ ☐	↓ ☐
	34 Afición o habilidad específica	↓ ☐	↓ ☐
Manejo de utensilios / enseres del hogar	36 Preparar una taza de café o un vaso de leche caliente	↓ ☐	↓ ☐
	37 Tareas del hogar (barrer, lavar los platos...)	↓ ☐	↓ ☐
	38 Preparar comidas sencillas o bocadillos	↓ ☐	↓ ☐

40	La duración de los cambios es superior a 6 meses	Sí ☐
-----------	--	------------------------------------

137-157	Los cambios se deben a problemas de salud o a una discapacidad física	No ☐
----------------	---	------------------------------------

Cumple el criterio A	Sí ☐	No ☐
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**LA VISUALIZACIÓN
DE ESTAS PÁGINAS
NO ESTÁ DISPONIBLE.**

Si desea obtener más información
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



5

DIRECTRICES PARA LA INTERVENCIÓN TRAS EL DIAGNÓSTICO



¿Qué hacer después del diagnóstico de demencia?

Guía resumen para los cuidadores de personas con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad intelectual que padecen demencia

Dra. Karen Dodd

Jefa del servicio de Psicología
Surrey and Borders Partnership NHS Trust

5.1. SECCIÓN 1. GUÍA RESUMEN PARA LA ASISTENCIA

5.1.1. Introducción

El diagnóstico de la demencia es el punto de partida para el desarrollo de un plan detallado e integrado para satisfacer las necesidades cambiantes de las personas con demencia, así como las de sus familias y de otros cuidadores.

La entrevista al informante del CAMDEX-DS y la evaluación neuropsicológica CAMCOG-DS proporcionan los medios para establecer de forma fiable la presencia o no de la demencia y para describir los cambios en las capacidades cognitivas y funcionales durante el transcurso de la enfermedad. Este capítulo va más allá del diagnóstico y presenta un resumen de los puntos clave que deben considerarse a la hora de planificar la asistencia de este colectivo. No pretende ser completamente exhaustiva, sino más bien proporcionar indicaciones o pautas para la buena práctica. Se incluye en este manual para asegurar que, una vez que el diagnóstico de la demencia se ha realizado, todos los interesados puedan darse cuenta de que todavía se puede hacer mucho para la asistencia de la persona y para mantener su calidad de vida.

En el apartado "Referencias bibliográficas" se incluyen algunas referencias sobre guías y recomendaciones adicionales en lengua inglesa.

5.1.2. Principios rectores

Los principios rectores de la asistencia a personas con síndrome de Down (SD) o con discapacidad intelectual (DI) que presentan demencia son los siguientes:

1. Mantener a la persona con demencia en el centro de la planificación del plan asistencial.
2. Asegurarse de que todas las personas y organismos pertinentes están trabajando en colaboración.
3. Tener visión de futuro y anticiparse a los cambios en las necesidades.
4. Utilizar las intervenciones que son conocidas por ser eficaces y personalizables para la persona.
5. Revisar y actualizar las necesidades de la persona y sus planes de asistencia.

A continuación, se describe con más detalle cada uno de ellos.

Mantener a la persona con demencia en el centro de la planificación del plan asistencial

Las necesidades de la persona con demencia son primordiales y satisfacerlas es lo que debe constituir la base para la atención y para los servicios proporcionados. Este principio de mantener a la persona en el foco central debe informar del tipo de asistencia individual que se proporciona a aquellas personas con SD o con DI que ahora han desarrollado demencia. A continuación se exponen algunos puntos generales que proporcionan un marco para la buena práctica clínica:

- (a) Cada persona experimenta la demencia de manera diferente. A pesar de que las orientaciones sobre las mejores prácticas son de gran ayuda, es importante considerar cómo podrían ser aplicadas de la mejor manera a cada persona en concreto. Fíjese en la persona y no en el diagnóstico, ya que el diagnóstico es solo una parte de nuestro conocimiento de la misma, pero no es la imagen completa.
- (b) El cuidado debe ser individualizado, basado en las necesidades específicas y en las elecciones de cada persona, en la medida en que tiene la capacidad de controlar su vida. De manera coherente con las buenas prácticas y con el cumplimiento de la ley, se debe ayudar a las personas a tomar las decisiones que tengan la capacidad de tomar (por muy simples que sean). En el caso de que carezcan de esta capacidad, las decisiones tomadas por los demás deben ser siempre en beneficio de la persona.
- (c) Es importante tratar de averiguar lo que la persona entiende acerca de lo que le está sucediendo, especialmente en las primeras etapas de la demencia, e intentar ofrecer explicaciones adecuadas, seguridad y apoyo. La evidencia sugiere, anecdóticamente, que muchas personas con discapacidad intelectual tienen conocimiento de lo que les ocurre y



las primeras etapas de la demencia, en particular, pueden ser muy aterradoras. A medida que la demencia progresa, la pérdida más devastadora para la persona es la “pérdida de sí mismo”.

- (d) Use lo que ya sabe acerca de la persona para informar de los cuidados que se le deben proporcionar. La información de las familias, los libros de historia de vida y otros documentos pueden ser fuentes de información útiles. Compruebe si tiene una historia detallada sobre la persona. ¿Dispone de un plan centrado en la persona que identifique sus deseos para el futuro? ¿Dispone de un plan de acción de salud elaborado a partir de este conocimiento? ¿Ha realizado un testamento o un documento de voluntades anticipadas de sus deseos futuros? ¿La persona tiene un libro de memoria o una historia de vida individualizada?
- (e) La asistencia más eficaz se proporciona cuando los cuidadores se dejan llevar por el ritmo de la persona en lugar de tratar de imponer plazos o límites de tiempo. La forma en que se interactúa con la persona ayuda a asegurar que la dignidad de la misma se conserva todo lo posible.
- (f) La principal consideración es mantener la mejor calidad de vida posible de la persona. Esto incluye asegurar que tenga una buena salud física y que esté libre de dolor y que sus necesidades psicológicas y sociales estén cubiertas, incluyendo realizar actividades de ocio y tener un nivel adecuado de participación en la comunidad y de implicación con la familia y con los amigos. Deben prepararse las acciones apropiadas para ayudar a la persona como respuesta ante cualquier problema de conducta que pueda surgir como resultado de la demencia o de los problemas asociados, como la enfermedad física o la depresión.

Cada persona debería tener un plan de atención individualizado. Este debe reflejar todos los criterios mencionados anteriormente junto con los siguientes:

- ❖ Debe existir un equilibrio entre la enseñanza de nuevas habilidades, el mantenimiento de las capacidades existentes y la búsqueda de adaptaciones que permitan disfrutar de las actividades a pesar de la pérdida de habilidades. Este equilibrio debe ser continuamente revaluado y cambiará a medida que progrese la demencia.
- ❖ Las personas compensan el deterioro en el funcionamiento haciendo uso de las habilidades conservadas. Esto puede significar que hay un conflicto entre las actividades adecuadas para una determinada edad frente a las actividades adecuadas para el nivel de memoria. Es importante que los servicios respondan a lo que la persona necesita o quiere en cada estadio de la demencia.

Asegurarse de que todas las partes del sistema están trabajando en colaboración

La efectividad de los cuidados en el transcurso de la demencia depende de la calidad de las colaboraciones establecidas entre la persona, las personas clave en su vida y los servicios asistenciales e institucionales. El alcance de los servicios que se necesita que estén involucrados irá

**LA VISUALIZACIÓN
DE ESTAS PÁGINAS
NO ESTÁ DISPONIBLE.**

Si desea obtener más información
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



5.1.4. Resumen

El diagnóstico de demencia debe ir seguido del desarrollo de un plan asistencial que reúna al mismo tiempo la información diagnóstica y el conocimiento de la persona. El plan no es rígido, al reconocer la naturaleza progresiva de la demencia y la importancia del desarrollo de estrategias de apoyo basadas en la observación y en la evaluación. Para dar apoyo a personas con DI y demencia se necesita un enfoque positivo, colocando a la persona afectada en el centro y asegurando el desarrollo de estrategias que optimicen su nivel de funcionamiento y su calidad de vida. Los cuidadores de personas con DI y demencia pueden marcar una diferencia real mediante las estrategias de apoyo que utilizan y mediante los cambios en el entorno.

Es esencial trabajar en colaboración con las familias, los organismos legales, las organizaciones privadas y las asociaciones de voluntariado, así como utilizar las habilidades de las distintas disciplinas conforme avanza el tiempo y la enfermedad.

5.2. SECCIÓN 2. LISTA DE CONTROL DEL ENTORNO

Adaptado de Surrey and Borders Partnership NHS Trust.

Este listado cubre algunas de las áreas que deben ser consideradas a la hora de evaluar el entorno del paciente con demencia. Ningún listado consigue ser totalmente completo, ya que dependerá del espacio físico que se está evaluando, de sus características ambientales y de las necesidades específicas de las personas que viven allí.



Característica	Detalles	Sí	No	No aplicable	Acción requerida
Calmado	¿El ruido externo es un problema? Especifique:				
	¿El ruido interno es un problema?				
	¿El ruido proviene de la gente?				
	¿El ruido proviene de la televisión o de la música?				
	¿El ruido proviene de los teléfonos?				
	Otro tipo ruido: especifique.				
	¿Los colores utilizados son adecuados?				
Predecible y con sentido	¿Las estancias se utilizan para una sola función y esa función está clara?				
	Si hay un uso doble o múltiple, ¿se utilizan señales diferentes para ayudar a la persona a identificar la actividad que está haciendo?				
	¿Se usa la misma estancia para una actividad específica de manera consistente?				
	¿Las salas específicas están bien señalizadas a una altura adecuada para las personas mayores?				
	¿Se utilizan diversas señales para identificar las distintas estancias?				
	¿Se utilizan señales visuales para ayudar a las personas a identificar las estancias?				
	¿Dispone de un entorno suficientemente previsible?				
	¿Las puertas cortafuegos están debidamente camufladas?				
Familiar	¿Los muebles son pequeños y familiares?				
	¿Se utilizan objetos o imágenes para facilitar la orientación?				
	¿Los objetos son comunes y de estilo tradicional?				
Adecuada-mente estimulante	¿Tiene vistas despejadas al exterior?				
	¿El nivel de ruido es adecuado?				
Seguro	¿Todas las salidas están vigiladas o tienen una alarma?				
	¿El jardín es seguro para pasear?				
	¿Se tienen en cuenta todos los riesgos de incendio?				
	¿La temperatura del agua en la cocina y en el baño está controlada?				
	¿Existen riesgos en las escaleras, escalones y superficies irregulares?				
	¿Existen posibles riesgos como, por ejemplo, esquinas afiladas, cuchillos u ollas calientes?				
	¿Hay acceso a través de las ventanas?				

**LA VISUALIZACIÓN
DE ESTAS PÁGINAS
NO ESTÁ DISPONIBLE.**

Si desea obtener más información
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



A la vanguardia de la evaluación psicológica

El **CAMDEX-DS** es un completo programa de evaluación para el **diagnóstico de demencia en personas con síndrome de Down o con capacidad intelectual leve o moderada**. Este colectivo tiene un riesgo especial de padecer demencia en etapas tempranas y presenta unas características que hace necesario el uso de instrumentos especialmente adaptados. Las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual ya presentan una disfunción cognitiva y funcional previa a la aparición de la demencia, por lo que el CAMDEX-DS pone un énfasis especial en determinar los cambios que se han producido en las capacidades de la persona con respecto a su nivel de funcionamiento previo más elevado, con el fin de diferenciar si el deterioro observado es debido a la demencia u otros trastornos mentales o a la disfunción previa.

El programa se compone de una **entrevista estructurada** al informante, una **evaluación directa** del paciente (CAMCOG-DS), una **guía para el diagnóstico** y una **guía para la intervención** posterior al mismo, proporcionando un método fiable para identificar la demencia y diferenciarla de otros trastornos comunes. El CAMCOG-DS proporciona información para la evaluación neuropsicológica del paciente que es de gran utilidad tanto para el diagnóstico clínico como para el diseño de los futuros apoyos y estrategias de intervención para mejorar su calidad de vida.



www.teaediciones.com

CAMDEX-DS

ISBN 978-84-15262-94-7



9 788415 262947